

ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ

Γενικά: Η μεθαμφεταμίνη - Meth (γνωστή στην αργκό με διάφορες ονομασίες, όπως: *Shisha, Chalk, Crank, Crystal, Cristy, Fast, Glass, Ice, Speed, Tina*) είναι μια εξαιρετικά εθιστική ψυχοδιεγερτική ουσία, παράγωγο της αμφεταμίνης. Κυκλοφορεί σε χάπια και σε μορφή λευκής (καφέ, κίτρινης ή ροζ) κρυσταλλικής σκόνης που καπνίζεται, σνιφάρεται ή ενίεται, η οποία είναι άοσμη, πικρή και διαλύεται εύκολα στο νερό ή σε αλκοόλ. Προκαλεί ευφορία, έξαψη, ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, σεξουαλική διέγερση - και γενικώς εικόνα παρόμοια με άλλων διεγερτικών όπως η κοκαΐνη - ενεργοποιώντας το ψυχολογικό σύστημα ανταμοιβής, αυξάνοντας τα επίπεδα της ντοπαμίνης, νορεπινεφρίνης και σεροτονίνης στον εγκέφαλο.

Κλινική εικόνα: Η οξεία ή μακροχρόνια χρήση και ο τρόπος λήψης, μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα από το καρδιαγγειακό, τους πνεύμονες, το γαστρεντερικό, τους νεφρούς, το ΚΝΣ, το δέρμα και τα δόντια. Έτσι, ο ασθενής μπορεί να εμφανισθεί στο ΤΕΠ με σοβαρή ΑΥ, υπερκινητικότητα, οξυθυμία, παραισθήσεις, μυδρίαση, ναυτία, ταχυαρρυθμίες (κολπική μαρμαρυγή ή κοιλιακές ταχυαρρυθμίες), στηθάγχη, καρδιακή ισχαιμία ή αορτικό διαχωρισμό, αλλά και σοβαρή υπόταση από εξάντληση κατεχολαμινών, οξεία ή χρόνια μυοκαρδιοπάθεια (οξεία ΣΚΑ-ΟΠΟ), οξεία ενδοκαρδίτιδα με υψηλό πυρετό (λόγω της ενδοφλέβιας χρήσης). Επίσης, μη καρδιογενές ΟΠΟ και πνευμονική υπέρταση μπορεί να προκύψουν από οξεία και χρόνια χρήση, καθώς και από νοθεύματα που εισάγονται κατά την ενδοφλέβια χρήση, όπως ταλκ ή άμυλο αραβοσίτου. Από το γαστρεντερικό έχει συσχετιστεί με μεσεντέρια ισχαιμία, έλκη και ισχαιμική κολίτιδα. Οξεία νεφρική βλάβη μπορεί να προκληθεί από ραβδομυόλυση, νεκρωτική αγγειίτιδα, διάμεση νεφρίτιδα ή σωληναριακή νέκρωση. Η εξέταση του στόματος αποκαλύπτει σοβαρές βλάβες, ειδικά των ούλων και οδόντων της άνω γνάθου “meth mouth”.

Διαφορική διάγνωση: Στη Δ/Δ περιλαμβάνονται τα εξής: υπερτασική αιχμή ή κρίση, OEM, επίταση ΣΚΑ-ΟΠΟ, οξύς αορτικός διαχωρισμός, θυρεοτοξίκωση, τοξικότητα από κοκαΐνη ή από άλλα παραισθησιογόνα (LSD, PCP), επιληψία, ΑΕΕ, υπαραχνοειδής αιμορραγία, κ.ά.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Ελέγχονται τα Α-Β-С-D-E του ασθενούς. Αν ο ασθενής βρίσκεται σε κώμα ($GCS \leq 8$) τότε πρέπει να διασωληνωθεί άμεσα ή να τοποθετηθεί λαρυγγική μάσκα ή συσκευή i-gel.
2. Εφόσον ο ασθενής βρίσκεται σε εγρήγορση, τότε χορηγείται οξυγόνο σε υψηλές ροές (ήτοι 8-12 lt/min O_2) με μάσκα οξυγόνου, με μάσκα Ambu ή με μάσκα Venturi (31-40 %).
3. Τοποθετείται ευρεία (3way) φλεβική γραμμή (#16-18G). Λαμβάνεται γενική αίματος και Β/Χ έλεγχος (Glu, Urea, Creat, AST, ALT, $K^+/Na^+/Ca^{++}$, CPK, Mgb, cTnI, BNP, CRP). Χορηγούμε άφθονα υγρά 1-3 lt N/S ή R/L, για ενυδάτωση και πρόληψη νεφρικής βλάβης.
4. Οι βενζοδιαζεπίνες αποτελούν - σαφώς - θεραπεία πρώτης γραμμής για την τοξικότητα της μεθαμφεταμίνης, αλλά συχνά απαιτείται επαναλαμβανόμενη και κλιμακούμενη δόση για επίτευξη θεραπευτικού αποτελέσματος και ύφεση των συμπτωμάτων. Έτσι, χορηγούμε:
 - ▶ 1-2 amp. Stedon 10 mg, εντός 100 ml N/S, σε έγχυση 10-20 λεπτών και επί μη ύφεσης
 - ▶ 5 amp. Stedon 10 mg, εντός 500 ml N/S, σε ελεγχόμενη συνεχή έγχυση 4-8 ωρών.
5. Χρήστες με έντονη διέγερση, ανθεκτικοί στη θεραπεία με τις βενζοδιαζεπίνες, πιθανώς να ωφεληθούν από τη χορήγηση αντιψυχωσικών, όπως η Αλοπεριδόλη και η Ολανzapίνη.
 - ▶ 1 amp. Aloperidin 5 mg ή 1 amp. Zyprexa 10 mg, [αμφότερα ενδομυϊκώς (im)].
6. Επί ΑΥ και ταχυκαρδίας, που δεν υφίστανται με την καταστολή, προτιμάται η Λαβεταλόλη:
 - ▶ 20-50 mg Trandate (4-10 ml, iv-bolus) και εν συνεχεία 20-100 mg (4-20 ml Trandate) εντός 250 ml N/S, στάγδην, σε χρόνο 30-60 λεπτά, αναλόγως ρυθμού (HR) και ΑΠ.
7. Επί σοβαρής ΑΥ χωρίς ταχυκαρδία, χορηγούνται Νιτρώδη που τιτλοποιούνται εύκολα:
 - ▶ 1 amp. Nitrolingual 25 mg, σε 250 ml D₅W, στις 5-30 μικροσταγόνες, αναλόγως ΑΠ.
8. Διακομιδή στο νοσοκομείο, ειδικά επί μη βελτίωσης ή επιδείνωσης της κλινικής εικόνας.